

Léntigos solares

(Basado en: Guía Clínica MINSAL Chile 2023, American Academy of Dermatology 2024, Fitzpatrick's Dermatology 2023, British Association of Dermatologists 2023, NCCN 2024 y UpToDate 2025).

1. Introducción y relevancia clínica

El **léntigo solar** (también conocido como *mancha senil*, *mancha de la edad* o *lentigo actínico*) es una **hiperpigmentación benigna y adquirida**, producida por la exposición crónica al sol.

Se caracteriza por **máculas marrones bien delimitadas**, sin relieve, que aparecen principalmente en **zonas fotoexpuestas**: cara, dorso de manos, antebrazos y escote.

Relevancia clínica

- Representa una de las **manifestaciones más comunes del fotoenvejecimiento cutáneo**.
 - No tiene potencial maligno directo, pero **es un marcador de daño solar acumulado** y, por ende, **de riesgo aumentado de cáncer de piel (especialmente carcinoma basocelular y espinocelular)**.
 - En EUNACOM, su importancia radica en **distinguirlo del melanoma y de la queratosis seborreica**, así como en conocer su **tratamiento estético y preventivo**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Mecanismo fisiopatológico

El léntigo solar se origina por una **proliferación localizada de melanocitos epidérmicos** estimulada por la **radiación ultravioleta (UVB y UVA)**.

Esto produce un **aumento de la síntesis de melanina** y una **distribución irregular del pigmento**, junto con **elastosis solar** (daño dérmico crónico).

La radiación induce:

- Daño directo al ADN de queratinocitos y melanocitos.
 - Liberación de **α -MSH** y **endotelina-1**, que estimulan la melanogénesis.
 - Producción de **especies reactivas de oxígeno (ROS)**, generando estrés oxidativo.
-

2.2. Factores predisponentes

Grupo	Ejemplos
Ambientales	Exposición crónica al sol, camas de bronceado
Raciales / Fototipo	Fototipos I–III (piel clara)
Edad	Mayores de 40 años
Genéticos	Predisposición familiar a hiperpigmentación
Hormonales / Fármacos	Algunos estrógenos o fotosensibilizantes (tetraciclinas, amiodarona)

2.3. Histopatología

- **Aumento de melanina en la capa basal.**
 - **Melanocitos ligeramente aumentados** en número, sin atipia.
 - **Elastosis solar dérmica** (colágeno fragmentado, fibras elásticas alteradas).
 - No hay proliferación irregular ni invasión dérmica (a diferencia del melanoma lentigo maligno).
-

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Lesiones características

- **Máculas planas, marrones o marrón-amarillentas**, de bordes bien definidos.
- Tamaño: 2 mm a 2 cm.
- Superficie lisa, sin descamación ni elevación.
- Distribución simétrica o múltiple en áreas expuestas (cara, dorso de manos, antebrazos, escote, parte superior de espalda).
- No producen síntomas (asintomáticas).

Color: uniforme o ligeramente irregular, más oscuro tras exposición solar.

3.2. Distribución típica

- **Cara:** frente, mejillas, nariz, sienes.
 - **Manos:** dorso, especialmente entre los 40–60 años.
 - **Escote y hombros:** por exposición solar crónica.
 - En personas con fototipo claro, suelen coexistir con arrugas y telangiectasias por daño solar.
-

3.3. Evolución

- Progresiva con la edad y la exposición solar acumulada.
 - No regresan espontáneamente.
 - Pueden coexistir con queratosis actínicas y otras lesiones de fotoenvejecimiento.
-

3.4. Diagnóstico diferencial

Lesión	Características distintivas
Efélides (pecas)	Aparecen en infancia; se aclaran en invierno
Melasma	Máculas marrones simétricas en rostro; inducido por hormonas
Queratosis seborreica	Lesión elevada, verrucosa, aspecto “pegado”
Melanoma lentigo maligno	Mácula pigmentada con bordes irregulares, color heterogéneo y crecimiento progresivo
Pigmentación postinflamatoria	Antecedente de inflamación o trauma local

3.5. Diagnóstico clínico (ABCDE negativo)

A diferencia del melanoma:

- **A** simetría: presente (lesión regular).
- **B** bordes: netos, regulares.
- **C** color: homogéneo.
- **D** diámetro: usualmente <1 cm.
- **E** evolución: estable o lenta, sin cambios abruptos.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico

El diagnóstico es **fundamentalmente clínico**, basado en:

1. Mácula marrón plana bien delimitada.
 2. Localización en áreas fotoexpuestas.
 3. Antecedente de exposición solar crónica.
 4. Ausencia de síntomas o cambios rápidos.
-

4.2. Dermatoscopía

Herramienta clave para diferenciar léntigo solar de lesiones malignas.

- **Patrón típico:**
 - Red o patrón reticulado pigmentario homogéneo.
 - Estructura tipo “dedal” o “fingerprint pattern”.
 - No hay velos azul-blancos ni puntos irregulares (sugestivos de melanoma).
-

4.3. Biopsia

Indicada **solo si hay sospecha de malignidad**, es decir:

- Cambios en tamaño, forma o color.
- Bordes irregulares.
- Coloración heterogénea.
- Historia de crecimiento rápido o sangrado.

Hallazgo histológico: aumento uniforme de melanina basal y melanocitos regulares sin atipia.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile, 2023)

El tratamiento es principalmente **estético y preventivo**, orientado a mejorar la apariencia y prevenir nuevas lesiones.

5.1. Medidas generales

- 1. **Fotoprotección estricta** (fundamental):
 - FPS $\geq$ 50, amplio espectro (UVA, UVB, luz visible).
 - Uso diario, reaplicar cada 2–3 horas.
 - Sombreros, ropa protectora, evitar exposición solar directa.
 - 2. **Educación al paciente:**
 - Explicar que las lesiones son benignas.
 - Enseñar autoevaluación y signos de alarma (cambios de color, sangrado, crecimiento).
 - 3. **Evitar fotosensibilizantes:**
 - Perfumes, cosméticos o fármacos que aumenten la sensibilidad solar.
-

5.2. Tratamiento médico (despigmentante tópico)

Fármaco	Mecanismo	Comentarios
Hidroquinona 2–4%	Inhibe tirosinasa y síntesis de melanina	Uso nocturno 8–12 semanas; riesgo de irritación u ocronosis si prolongado
Ácido retinoico (tretinoína)	Promueve renovación celular y dispersión del pigmento	Útil como coadyuvante

Ácido kójico / azelaico / niacinamida	Inhiben melanogénesis	Alternativas seguras, uso prolongado
---------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------

Combinaciones despigmentantes (hidroquinona + tretinoína + corticoide suave)	Efecto sinérgico	Supervisar efectos secundarios
--	------------------	--------------------------------

Los despigmentantes requieren **mínimo 2–3 meses** de uso continuo y siempre acompañarse de **fotoprotección diaria**.

5.3. Procedimientos dermatológicos (según tipo y extensión)

Procedimiento	Mecanismo	Indicaciones
Crioterapia con nitrógeno líquido	Dstrucción selectiva de melanocitos	Lesiones aisladas pequeñas
Láser Q-switched (532 nm o 755 nm)	Fragmenta pigmento melánico	Léntigos múltiples faciales o en manos
Luz pulsada intensa (IPL)	Fototermólisis selectiva	Tratamiento estético integral
Peelings químicos (ácido glicólico, TCA 15–20%)	Exfoliación y regeneración epidérmica	Lesiones difusas
Microdermoabrasión	Eliminación mecánica del estrato córneo	Coadyuvante

Importante: todos los procedimientos deben realizarse por dermatólogo entrenado, bajo estricto control de fotoprotección postratamiento para evitar hiperpigmentación postinflamatoria.

5.4. Seguimiento

- Reevaluación cada 3–6 meses para controlar respuesta y descartar transformación.
 - En pacientes con múltiples léntigos o antecedentes de melanoma, seguimiento anual permanente.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Hiperpigmentación postinflamatoria	Por procedimientos agresivos o sin fotoprotección
Hipopigmentación residual	Rara, secundaria a crioterapia intensa
Recurrencia	Frecuente si persiste exposición solar
Confusión diagnóstica	Puede confundirse con melanoma lentigo maligno
Cambios malignos	No ocurre transformación directa, pero es marcador de daño solar acumulado

Pronóstico:

- Benigno, con excelente evolución si se mantiene fotoprotección.
 - Las lesiones pueden recidivar, pero **no se malignizan**.
 - Su presencia debe motivar **evaluación cutánea completa** por riesgo de otras lesiones actínicas.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **Mácula marrón bien delimitada, en zonas fotoexpuestas, en adulto mayor = léntigo solar.**
 2. Es un **marcador de daño solar acumulado**, no una lesión precancerosa directa.
 3. No descama, no pica, no duele y **no cambia rápidamente.**
 4. **Fotoprotección estricta** es el tratamiento preventivo esencial.
 5. En EUNACOM, suele confundirse con **melanoma lentigo maligno** (éste es irregular, asimétrico y crece progresivamente).
 6. **Láser o crioterapia** son opciones efectivas si se busca tratamiento estético.
 7. El **uso prolongado de hidroquinona (>6 meses)** puede producir ocronosis exógena.
-



Errores comunes

- Diagnosticar como melanoma sin criterios ABCDE.
 - No diferenciar de queratosis seborreica o melasma.
 - Tratar sin fotoprotección, generando hiperpigmentación postinflamatoria.
 - Destruir sin confirmación dermatoscópica en lesiones atípicas.
 - Ignorar que los léntigos solares son **indicadores de riesgo** para otras lesiones por daño actínico.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **léntigo solar** es una **hiperpigmentación benigna adquirida**, secundaria al **daño solar crónico**.
2. Se manifiesta como **máculas marrones planas, bien delimitadas, sin relieve**, en áreas fotoexpuestas.
3. Es **benigno**, pero actúa como **marcador de daño solar y riesgo de cáncer cutáneo**.
4. El **diagnóstico es clínico**, apoyado por **dermatoscopia**, y la **biopsia** se reserva para casos atípicos.
5. El **tratamiento principal es la fotoprotección**, complementado con **despigmentantes o procedimientos estéticos**.
6. La **recurrencia es frecuente** si no se mantiene protección solar constante.
7. En **EUNACOM**, la clave está en diferenciarlo de melanoma (asimétrico, irregular, cambiante) y de melasma (simétrico, hormonal, facial).